



## FICHE BONNE CONDUITE n°13 - CONTENTION PHYSIQUE PASSIVE

### CATEGORIE AIDE A LA PERSONNE

Dans certaines situations, je peux intervenir chez une personne pour laquelle une contention physique passive est en place (ex : barrières de lit, ceintures au lit ou au fauteuil etc.), ce qui empêche la personne de mobiliser tout ou partie de son corps. La contention physique passive permet d'assurer la sécurité de la personne (ex : éviter une chute, de la déambulation ou une fugue), mais présente des risques importants : agitation, syndrome d'immobilisation, perte d'autonomie (ex : troubles de la continence, perte de mobilité), troubles cognitifs, sentiment de mise à l'écart, déshumanisation, résignation, atrophie, atteintes cutanées etc.

Le recours à la contention doit rester exceptionnel et relève exclusivement d'une prescription médicale.

#### REGLES D'OR

- ✓ J'alerte l'association lorsque la personne accompagnée se met en **danger** (ex : risque de chute du lit, déambule dans le logement ou à l'extérieur) afin que soit évalué le besoin d'une contention physique passive
- ✓ Je ne mets pas et/ou je n'enlève pas une contention de ma propre initiative, ou à la demande/ sous pression des aidants ou des proches. **Une prescription médicale est nécessaire** et doit être respectée.
- ✓ Je suis les consignes d'utilisation de la contention physique passive (ex : heures de pose ou de dépose, niveau de serrage de la ceinture).
- ✓ Pour l'aide à la toilette, je peux détacher ou défaire la contention physique passive temporairement (ex : baisser la barrière de lit). Je la replace à l'identique après le geste.
- ✓ Je trace les informations dans le cahier de liaison

#### POINTS DE VIGILANCE

- ✓ Si aucune contention physique passive n'a été prescrite par le médecin, alors je n'utilise pas les matériels ou accessoires (ex : ceinture du fauteuil, barrière de lit), même s'ils sont présents.
- ✓ J'alerte l'association en cas **de demande inhabituelle** (ex : enfermer une personne vulnérable chez elle) ou lorsque les proches mettent des contentions à la personne accompagnée sans prescription médicale et/ou des contentions artisanales (ex : attacher la personne à son fauteuil avec un foulard etc.)
- ✓ J'alerte l'association si je constate un risque pour la personne en lien avec la contention (ex : membres bloqués, risque de chute, risque d'étranglement etc.)
- ✓ Si la personne accompagnée est en situation d'urgence et peut gravement mettre sa vie en danger à court terme ou celle des autres, alors je contacte les services d'urgence (ex : 15 SAMU, 17 police) puis l'association



### Comment réagir si ?

- La personne accompagnée peut exprimer un inconfort important ou un désaccord avec la contention physique passive. Je rassure la personne, je cherche à diminuer l'inconfort, et j'explique les raisons pour lesquelles cette contention a été mise en place, en concertation avec la famille, l'association et les professionnels assurant le suivi (ex : médecin traitant)

### Cas particulier des barrières de lit

Sont considérés comme contention physique passive les cas suivants :

- Lit dont les deux barrières sont relevées
- Lit dont 1 seule barrière est relevée mais se trouvant contre un mur du côté non relevé, empêchant toute sortie du lit en autonomie.

Seul le médecin peut prescrire l'utilisation des barrières de lit comme contention physique passive.

### PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Pour l'aide à la toilette ou l'aide à la mobilité, je défais les contentions physiques passives (ex : barrière du lit) afin d'éviter les postures contraignantes (ex : se pencher au-dessus d'une barrière).
- ✓ Une personne immobilisée un certain temps peut avoir des difficultés à se mobiliser (léthargie des muscles). Je tiens compte du manque de tonus musculaire de la personne, et je suis vigilant au risque de chute et à tout impact sur ma santé physique (ex : mobiliser mon dos voire être entraîné dans la chute). Je me réfère à la fiche « Aide à la mobilité ».
- ✓ Vivre sous contention physique passive peut avoir des conséquences sur le bien-être de la personne accompagnée (ex : déprime, agitation etc.). Intervenir auprès d'elle peut avoir un impact psychologique sur moi (ex : stress, tristesse...).
- ✓ Si la situation devient trop pesante, je n'hésite pas à demander de l'aide à mon association pour qu'elle trouve une solution (ex : trouver un relais).
- ✓ Si j'en ressens la nécessité, je peux en parler à mon entourage, à mon médecin traitant, ou contacter le dispositif de soutien psychologique PROS-CONSULTE au 0805 23 23 40 ou en utilisant l'application mobile